HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Infirmier organisateur de l'accueil – Fondamentaux

Mr Giovanni SILVETTI

25 septembre 2026

La formation – Infirmier Organisateur de l'Accueil

Objectifs pédagogiques

- **Identifier** le cadre réglementaire et professionnel de la fonction IOA.
- **Décrire** le rôle organisationnel et les missions de l'IOA.
- **Identifier et appliquer** les principes fondamentaux du tri infirmier à l'accueil des urgences.
- **Évaluer, prioriser et orienter** les patients à partir de leur situation clinique et de l'outil de tri institutionnel.
- **Adapter** sa communication avec les patients, les accompagnants et les différents professionnels.
- **Appliquer** les procédures et protocoles institutionnels en lien avec la fonction IOA.

3 temps



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

Sommaire



1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA
2. ÉVALUER & TRIER
3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES
4. SÉCURISER SA PRATIQUE

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

« 5 patients arrivent. Qui prend-on en premier ? »

Douleur thoracique	Accident de la voie publique	Plaie avec saignement actif	Douleur abdominale	Personne âgée confuse

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

L'IOA : une fonction née d'un besoin



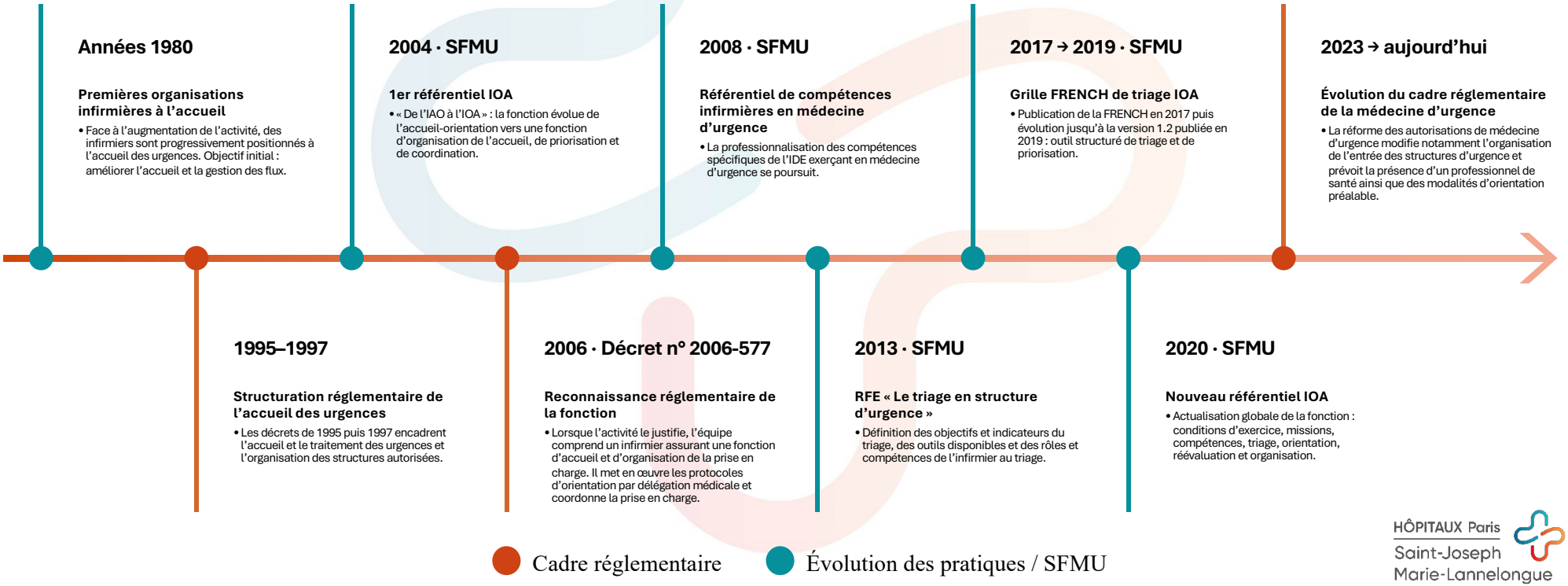
Identifier rapidement celui qui ne peut pas attendre

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

D’un besoin de terrain à une fonction structurée



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Une fonction clinique, relationnelle et organisationnelle



La mission générale de l'IOA définie dans le référentiel de la SFMU :

« Accueillir de façon personnalisée le patient et ses accompagnants à leur arrivée, définir les priorités de soins en fonction des besoins exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du lieu de soins adapté. Ces actions ont pour objectif d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et de leurs accompagnants dès l'accueil. Elles sont menées en lien constant avec le médecin référent chargé de superviser le fonctionnement du service et la gestion des flux. »

→ **Accueillir le patient, évaluer ses besoins, définir une priorité de soins et organiser une prise en charge adaptée.**

IOA = 8 missions

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Une fonction clinique, relationnelle et organisationnelle

IOA = 8 missions

1. **Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences**
2. **Décider du lieu de soins adapté**
3. **Installer**
4. **Informer, aider, rassurer**
5. **Surveiller**
6. **Anticiper**
7. **Communiquer et coordonner**
8. **Enseigner**

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions de l'IOA

1

Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences

L'IOA accueille = soin relationnel auprès du patient.
→ Objectif : permettre de comprendre et d'accepter les soins dans les meilleures conditions :
→ gestion du stress, information, écoute, installation, confort, prise en charge de la douleur

l'IOA évalue rapidement le degré d'urgence afin de privilégier la prise en charge du patient présentant un caractère réel d'urgence.

Le tri doit s'effectuer à partir d'outils spécifiques utilisés dans le service (Échelle de tri comme la FRENCH) et sur des protocoles écrits et signés par le responsable médical

L'IOA identifie les besoins et les ressources dont le patient aura besoin.

L'IOA s'inscrit dans la démarche diagnostique infirmière, qui est partie intégrante du rôle propre infirmier.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

L'accueil en 4 étapes

1 Accueil

Présentation (prénom, fonction, intérêt de l'évaluation, variation ordre de passage : temps d'attente environ)

→ **information indispensable** = acceptation de l'attente + diminution de l'anxiété.

= Soins relationnel, relation de confiance.

2 Analyse

Examen clinique infirmier :

Examen physique (5 sens – Ø goût).

- Vue
- Toucher
- Odorat
- Ouïe

3 Entretien

Entretien : 3Q2C

- Qui ?
- Quoi ?
- Quand ?
- Comment ?
- Combien ?

Paramètres vitaux :

- FC
- TA
- SpO2
- FR
- Température
- Douleur

4 Décision

Décision du niveau de tri & choix de la zone de soins en fonction des éléments recueilli et des critères de gravité ou non du patient

→ Grille de tri

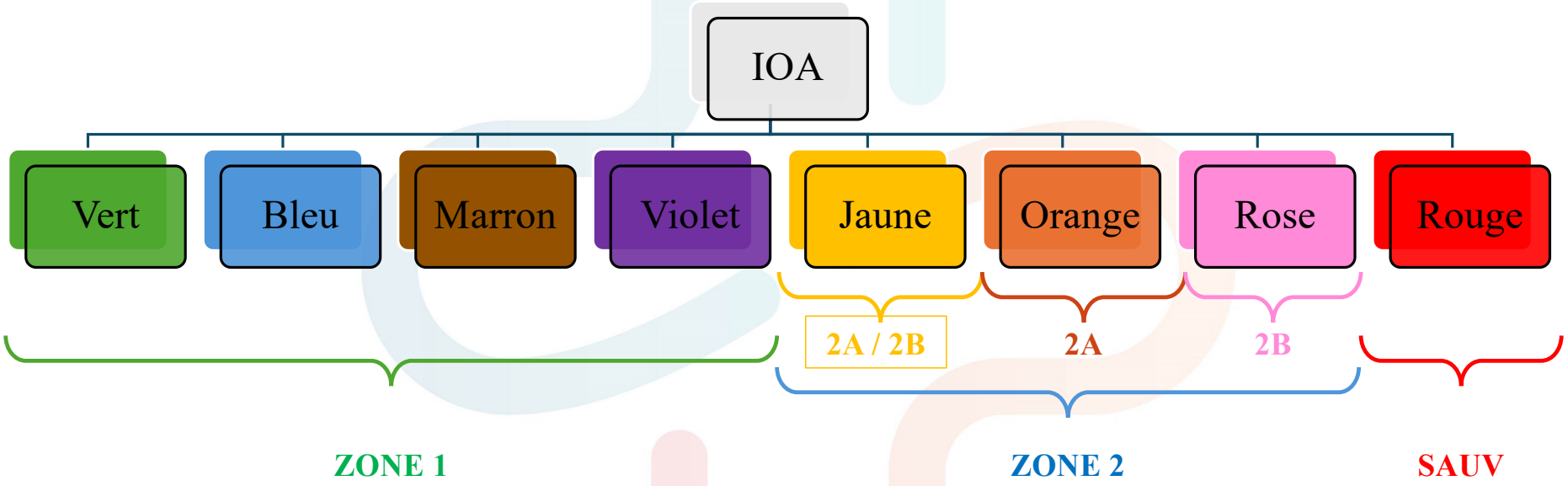
Accueillir — *Évaluer* — *Tri*

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Le tri en fonction des zones



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

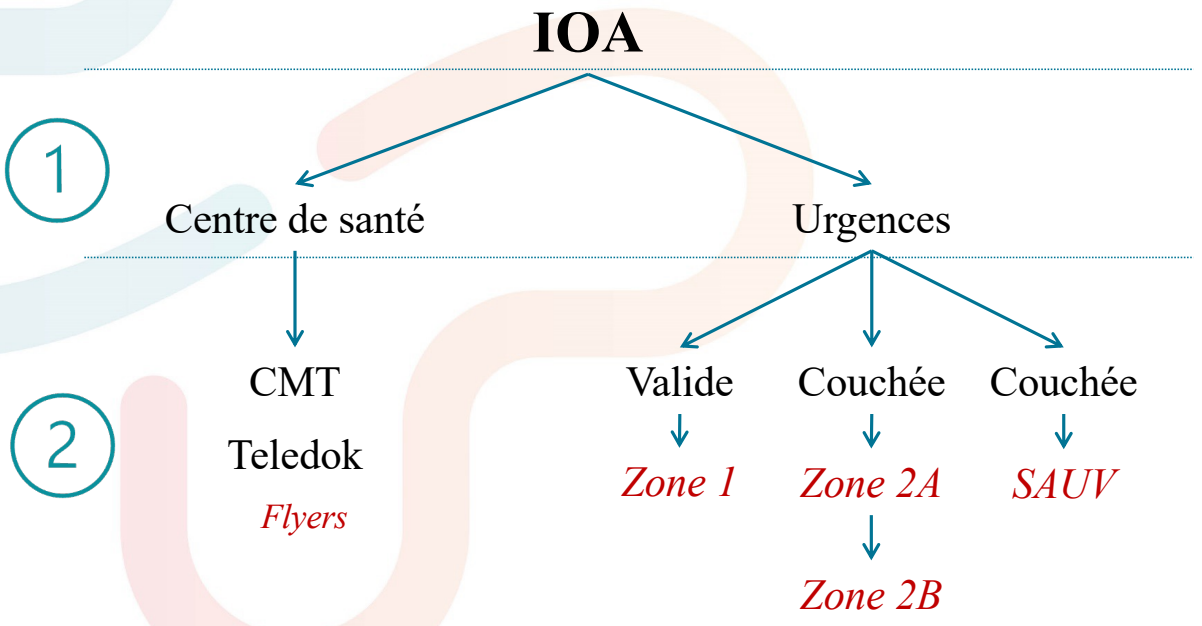
Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

2

Décider du lieu de soins adapté



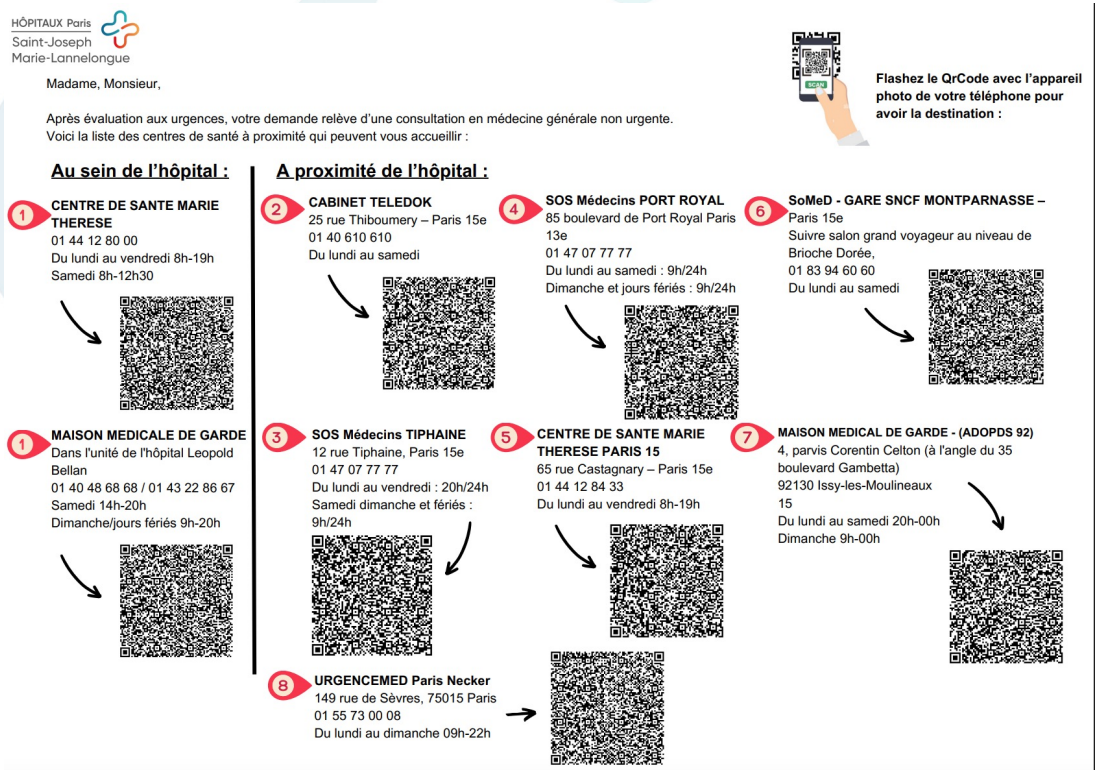
HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

Flyers



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Madame, Monsieur,

Après évaluation aux urgences, votre demande relève d'une consultation en médecine générale non urgente.
Voici la liste des centres de santé à proximité qui peuvent vous accueillir :

Flashez le QrCode avec l'appareil photo de votre téléphone pour avoir la destination :

Au sein de l'hôpital :

1 **CENTRE DE SANTE MARIE THERESE**
01 44 12 80 00
Du lundi au vendredi 8h-19h
Samedi 8h-12h30

1 **MAISON MEDICALE DE GARDE**
Dans l'unité de l'hôpital Leopold Bellan
01 40 48 68 68 / 01 43 22 86 67
Samedi 14h-20h
Dimanche/jours fériés 9h-20h

A proximité de l'hôpital :

2 **CABINET TELEDOK**
25 rue Thiboumery – Paris 15e
01 40 610 610
Du lundi au samedi

3 **SOS Médecins TIPHAINE**
12 rue Tiphaine, Paris 15e
01 47 07 77 77
Du lundi au vendredi : 20h/24h
Samedi dimanche et fériés : 9h/24h

4 **SOS Médecins PORT ROYAL**
85 boulevard de Port Royal Paris 13e
01 47 07 77 77
Du lundi au samedi : 9h/24h
Dimanche et jours fériés : 9h/24h

5 **CENTRE DE SANTE MARIE THERESE PARIS 15**
65 rue Castagnary – Paris 15e
01 44 12 84 33
Du lundi au vendredi 8h-19h

6 **SoMeD - GARE SNCF MONTPARNASSE –**
Paris 15e
Suivre salon grand voyageur au niveau de Brioche Dorée,
01 83 94 60 60
Du lundi au samedi

7 **MAISON MEDICAL DE GARDE - (ADOPDS 92)**
4, parvis Corentin Celton (à l'angle du 35 boulevard Gambetta)
92130 Issy-les-Moulineaux
15
Du lundi au samedi 20h-00h
Dimanche 9h-00h

8 **URGENCEMED Paris Necker**
149 rue de Sèvres, 75015 Paris
01 55 73 00 08
Du lundi au dimanche 09h-22h

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

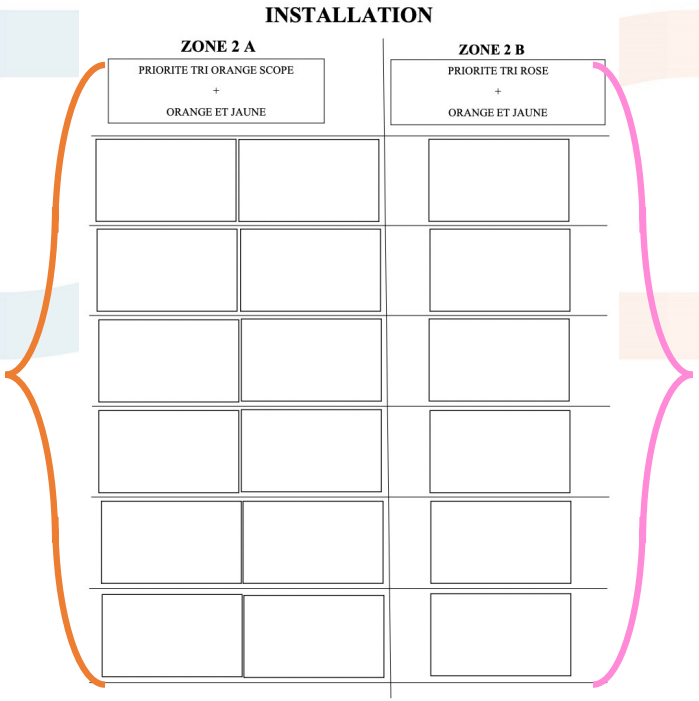
Les missions

Installation Zone couchée

Zone 2A

Orange Scopé

Pas de tri rose



Zone 2B

Priorité tri rose

Pas de suspicion d'occlusion

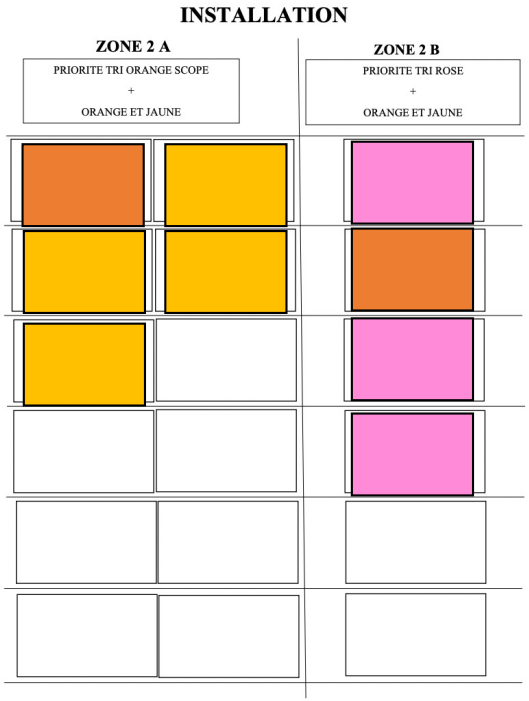
HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

Installation Zone couchée



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

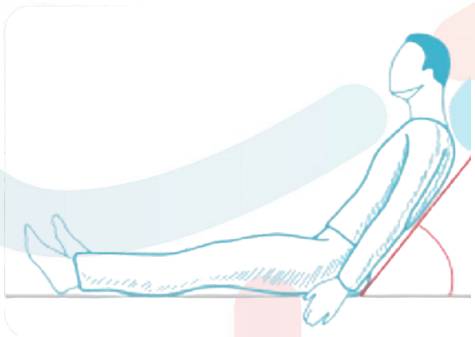
1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

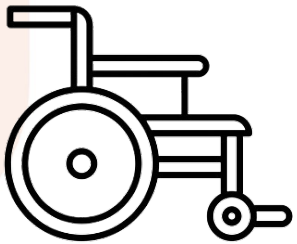
3

Installer

L'IOA installe ou fait installer le patient en fonction de ses besoins









HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

4

Informer, aider, rassurer

L'IOA informe le patient et ses accompagnants de l'organisation des soins, du fonctionnement du service, du délai et des raisons d'une attente éventuelle.

L'IOA rassure les familles et les informe des soins en cours et à venir, de l'attente des examens de laboratoire et/ou d'imagerie.

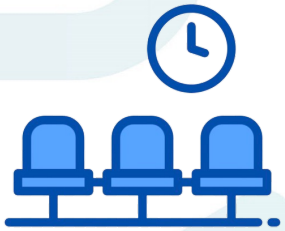
L'IOA est en relation permanente avec les médecins et infirmier(e)s effectuant les soins des différentes zones.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

4

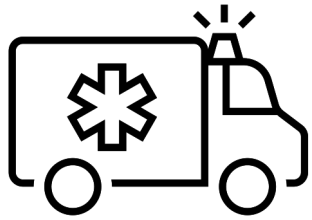












HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Accompagnant

SAU

IOA

Zone Valide

Zone Couchée

SAUV

*

*

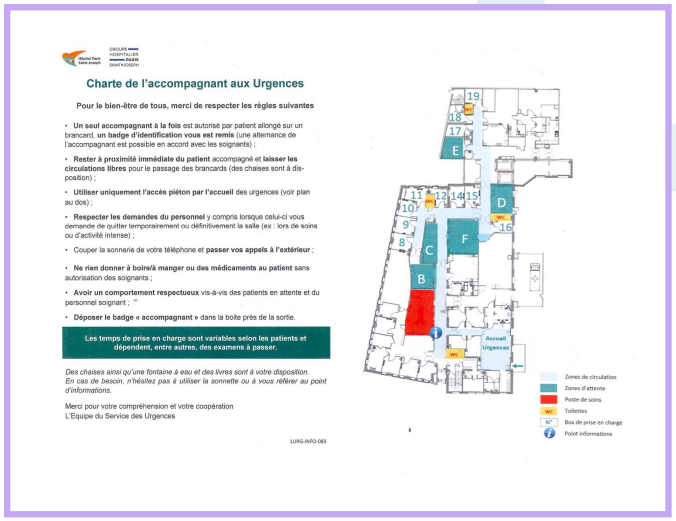
Lits d'urgences

2 Accompagnants / patient

Charte

Badge

Flyer



Charte de l'accompagnant aux Urgences

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les règles suivantes

- **Un seul accompagnant à la fois** est autorisé par patient allongé sur un brancard, **un badge d'identification vous est remis** (une alternance de l'accompagnant est possible en accord avec les soignants) ;
- **Rester à proximité immédiate du patient** accompagné et **laisser les circulations libres** pour le passage des brancards (des chaises sont à disposition) ;
- **Utiliser uniquement l'accès piéton par l'accueil** des urgences (voir plan au dos) ;
- **Respecter les demandes du personnel** y compris lorsque celui-ci vous demande de quitter temporairement ou définitivement la salle (ex : lors de soins ou d'activité intense) ;
- Couper la sonnerie de votre téléphone et **passer vos appels à l'extérieur** ;
- **Ne rien donner à boire/à manger ou des médicaments au patient** sans autorisation des soignants ;
- **Avoir un comportement respectueux** vis-à-vis des patients en attente et du personnel soignant ; "
- **Déposer le badge « accompagnant »** dans la boite près de la sortie.

Les temps de prise en charge sont variables selon les patients et dépendent, entre autres, des examens à passer.

Des chaises ainsi qu'une fontaine à eau et des livres sont à votre disposition. En cas de besoin, n'hésitez pas à utiliser la sonnette ou à vous référer au point d'informations.

Merci pour votre compréhension et votre coopération
L'Equipe du Service des Urgences

1URG-INFO-083

Zones de circulation
Zones d'attente
Poste de soins
Toilettes
Box de prise en charge
Point informations

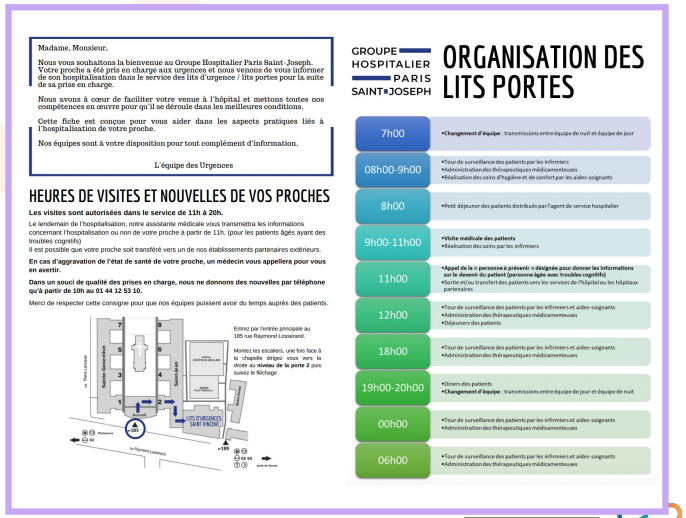


ACCOMPAGNANT

Service des urgences

En cas de "fin de vie", il n'y a pas de restrictions.

**Selon l'appréciation du soignant*



Madame, Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. Votre proche a été pris en charge aux urgences et nous venons de vous informer de son hospitalisation dans le service des lits d'urgence / lits portes pour la suite de sa prise en charge.

Nous avons à cœur de faciliter votre venue à l'hôpital et mettons toutes nos compétences en œuvre pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions.

Cette fiche est conçue pour vous aider dans les aspects pratiques liés à l'hospitalisation de votre proche.

Nos équipes sont à votre disposition pour tout complément d'information.

L'équipe des Urgences

HEURES DE VISITES ET NOUVELLES DE VOS PROCHES

Les visites sont autorisées dans le service de 11h à 20h.

Le lendemain de l'hospitalisation, notre assistante médicale vous transmettra les informations concernant l'hospitalisation ou non de votre proche à partir de 11h. (pour les patients âgés ayant des troubles cognitifs)
Il est possible que votre proche soit transféré vers un de nos établissements partenaires extérieurs.

En cas d'aggravation de l'état de santé de votre proche, un médecin vous appellera pour vous en avertir.

Dans un souci de qualité des prises en charge, nous ne donnons des nouvelles par téléphone qu'à partir de 10h au 01 44 12 53 10.

Merci de respecter cette consigne pour que nos équipes puissent avoir du temps auprès des patients.

Entrez par l'entrée principale au 185 rue Raymond Losserand.

Montez les escaliers, une fois face à la chapelle dirigez vous vers la droite au **niveau de la porte 2** puis suivez le fléchage

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

ORGANISATION DES LITS PORTES

7h00	•**Changement d'équipe** : transmissions entre équipe de nuit et équipe de jour
08h00-9h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers •Administration des thérapeutiques médicamenteuses •Réalisation des soins d'hygiène et de confort par les aides-soignants
8h00	•Petit déjeuner des patients distribués par l'agent de service hospitalier
9h00-11h00	•**Visite médicale des patients** •Réalisation des soins par les infirmiers
11h00	•**Appel de la « personne à prévenir » désignée pour donner les informations sur le devenir du patient (personne âgée avec troubles cognitifs)** •Sortie et/ou transfert des patients vers les services de l'hôpital ou les hôpitaux partenaires
12h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses •Déjeuners des patients
18h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses
19h00-20h00	•Dîners des patients •**Changement d'équipe** : transmissions entre équipe de jour et équipe de nuit
00h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses
06h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses

Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

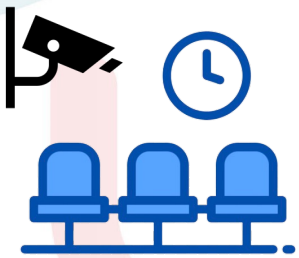
Les missions

5

Surveiller

L'IOA assure la surveillance régulière de la salle d'attente, coordonne les informations destinées aux accompagnants et aux familles, apaise au mieux les tensions afin de prévenir toutes formes de violences.

L'IOA est amené(e) à surveiller les salles d'attentes des patients en attente de prise en charge médicale.





HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

6

Anticiper

L'IOA *peut* assurer une liaison directe avec les centres de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers, les centres de réception et de régulation des appels du SAMU, la police et anticipe la venue des patients à risque (détenus, patient consultant sur réquisition judiciaire...).







HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions



Règles IOA

Délai d'attente avant IOA ne devant pas excéder **30** minutes

IOA ne devant pas excéder **5/10** minutes

Au-delà de **30** minutes ET/OU **5** patients en attente

=

IOA 3

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

Communiquer ET coordonner

7

Pour favoriser une bonne communication et essayer d'apaiser au mieux les craintes et/ou angoisses des accompagnants, l'IOA centralise les informations, localise les patients afin de pouvoir répondre à toute demande.

Les familles doivent, par sa présence et ses informations, trouver un(e) interlocuteur(trice) référent(e) performant(e).



GIO
79.47



MAO
78.63



IOA SAUV
72.77



IDE PSY
76.77



IDE Z2A
73.37



IDE Z2B
83.29

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

1. COMPRENDRE LA FONCTION IOA

Les missions

Enseigner

8

Dans le contexte spécifique de l'accueil et du tri dans un service d'urgences,

L'IOA encadre les étudiants infirmiers en stage et les infirmier(e)s en stage d'intégration.

Il est important de souligner que l'IOA assure la formation pratique des nouveaux infirmiers qui auront, à la suite d'une formation spécifique, la possibilité d'assurer cette fonction.



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Une méthode : Le 3Q2C

Outil permettant de réaliser l'interrogatoire clinique

QUI	Age, Sexe, ATCD, épisodes similaires, TTT Spécifiques
QUOI	Motif (attention peut être différent à l'arrivée)
QUAND	Date et heure de début
COMMENT	Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution
COMBIEN	Intensité du symptômes, pics, évolution

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Une méthode : Le 3Q2C

3Q2C

QUI

Age
Sexe
ATCD
épisodes similaires
TTT Spécifiques

QUAND

Date et heure de début

QUOI

Motif (attention peut être différent à l'arrivée)

COMMENT

Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution

COMBIEN

Intensité du symptômes, pics, évolution

Me W, 31 ans.

Patiente vient pour douleurs au niveau de l'hypochondre droit.
Douleur d'apparition brutale ce jour vers 18h, avec nausées sans vomissements.
Pas de SFU, pas de troubles du transit associés.
DDR : Il y a 2 semaines, patiente sous contraception et pas de risque de grossesse.

A l'IOA, douleurs présente, intensifié à la palpation, sans irradiation.
Abdomen souple.
Présente des nausées.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

ROUGE
Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate
CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
ACR
Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)
FC > 140 avec ECG et après avis MAO ou FC < 45
Douleur thoracique avec modification ECG
TAS > 220mmHg symptomatique
Patient présentant un **QSofa > ou = 2 critères.**
RESPIRATOIRE
FR < 8
SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22
Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%
Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée
NEUROLOGIQUE
Coma avec score de Glasgow < 9
Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)
DIGESTIF
Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)
INFECTIOLOGIE
Hypothermie avec **modification ECG**
INTOXICATION *quelle que soit la nature*
Avec modification ECG
MÉTABOLIQUE
Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5 **OU** Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3
Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG **OU** Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG
TRAUMATOLOGIE
Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils)
Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place
Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL / tête / périnée
Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical
Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO
PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
ACR / Coma

SAUV

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

ORANGE
Patient alité présentant une constante d'alerte ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgente
CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
Syncope sans prodromes *(À SCOPER)*
Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG *(À SCOPER)*
RESPIRATOIRE
SpO2 < 94% sous O2 < 6L/min ET FR > 22 *(À SCOPER)*
NEUROLOGIQUE
Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 – 14
> 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) *(À SCOPER)*
INTOXICATION *quelle que soit la nature*
Glasgow < 15 et > 9
MÉTABOLIQUE
Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15
Hyperkaliémie > 6 mmol/L *(À SCOPER)*
TRAUMATOLOGIE
Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire)
Plaie du scalp de grande taille très hémorragique **après accord du MAO**
DOULEUR
EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN)
EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Oxynorm

Zone 2A ***ou*** *Zone 2B*

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

JAUNE
Patient alité mais ne présentant ni signe de gravité, ni d'urgence

Zone 2A* ou *Zone 2B

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

ROSE
Patient stable sur le plan hémodynamique, monomotif, nécessitant d'être allongé
Rétention aigue d'urine
Douleur de la fosses lombaires hyperalgiques non fébrile (hors 1er épisode + de 60 ans).
Douleur des OGE de plus de 24h, non brutale.
Déficit neurologique (moteur, sensitif, sensoriel ou du langage) + de 6h et – de 24h (Appel IDE Zone 2B)
Problème de matériel médical
Mono traumatisme de membre hors tronc
Traumatisme **bassin/hanche** ne pouvant pas être en zone valide.
TC sans signe de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant).**
Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères augmentés.**
Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
Anémie sans autres anomalies (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
Erythème et/ou œdème d'un membre isolé, hors anaphylaxie.
Plaie non traumatique (ulcères MI, escarres hors stade IV).
Plaie superficielle hors main, ou zones à risque du visage.
Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**
IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
Douleur abdominale isolée du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur thoracique atypique du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur articulaire, de membre, sciatique et ou rachidienne sans fièvre.
HTA non symptomatique (suppression dans le tri orange de TAS > 22 mmHg asymptomatique)
Membre chaud, douloureux, OMI.
FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :
+ de 75 ans, sans problème sociaux
Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.

Zone 2B

Si Zone 2B fermées, le tri rose va en zone 2

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

VIOLET
Patient valide présentant un des motifs suivants :
Crise d'asthme Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive Douleur des organes génitaux externe (OGE). Patient arrivant pour un **problème psychiatrique (sans problème somatique) ou CPU psychiatrique.** Patient arrivant avec un **diagnostic chirurgical avéré** Patient adressé des **urgences gynécologiques** Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation) **Patient(e) victime de violences conjugales (installation en box)**

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

MARRON
Consultation Post-urgences (CPU) de Psychiatrie Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique et sans besoin d'évaluation somatique a priori)

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

BLEU
Patient valide ne présentant ni signes de gravité, ni d'urgence
Plaies Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation) Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

La grille de tri

VERT
Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées
AES
CNA
Panaris collecté isolé
Consultation simple ne pouvant être réorientée

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

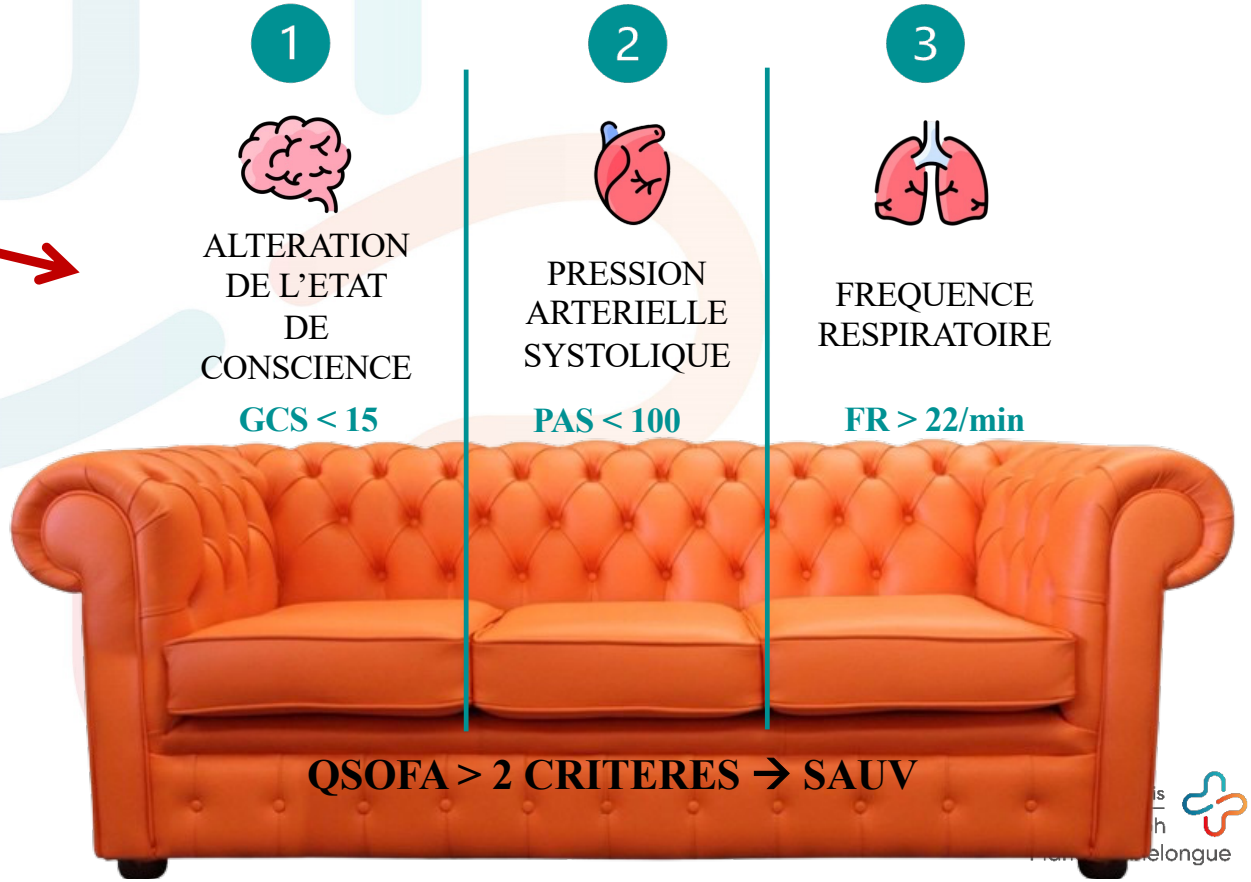
2. ÉVALUER & TRIER

Le QSofa

ROUGE

Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- ACR - Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités) - FC > 140 ou FC < 45 - Douleur thoracique avec modification ECG - TAS > 220mmHg symptomatique - Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères.
RESPIRATOIRE
- FR < 10 - SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22 - Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94% - Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée
NEUROLOGIQUE
- Coma avec score de Glasgow < 9 - **Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)**
DIGESTIF
- Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)
INFECTIOLOGIE
- Hypothermie avec **modification ECG**
INTOXICATION quelle que soit la nature
- **Avec modification ECG**
MÉTABOLIQUE
- Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5 - Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3 - Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG - Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG
TRAUMATOLOGIE
- Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils) - Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place - Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL – tête – périnée - Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical - Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO
PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
- ACR - Coma

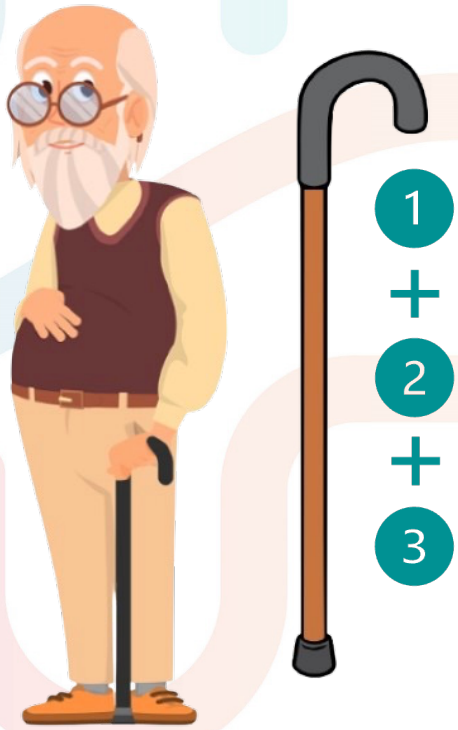


Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Le FTPA

ROSE
Patient stable sur le plan hémodynamique, monomotif, nécessitant d'être allongé
Rétention aigue d'urine
Douleur de la fosses lombaires hyperalgiques non fébrile (hors 1er épisode + de 60 ans).
Douleur des OGE de plus de 24h, non brutale.
Déficit neurologique (moteur, sensitif, sensoriel ou du langage) + de 6h et – de 24h (Appel IDE Zone 2B)
Problème de matériel médical
Mono traumatisme de membre hors tronc
Traumatisme **bassin/hanche** ne pouvant pas être en zone valide.
TC sans signe de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant).**
Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères augmentés.**
Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
Anémie sans autres anomalies (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
Erythème et/ou œdème d'un membre isolé, hors anaphylaxie.
Plaie non traumatique (ulcères MI, escarres hors stade IV).
Plaie superficielle hors main, ou zones à risque du visage.
Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**
IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
Douleur abdominale isolée du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur thoracique atypique du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur articulaire, de membre, sciatique et ou rachidienne sans fièvre.
HTA non symptomatique (suppression dans le tri orange de TAS > 22 mmH[illegible]symptomatique)
Membre chaud, douloureux, OMI.
FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :
+ de 75 ans, sans problème sociaux
Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.



1. ÂGE > 75 ans
+
2. PAS DE PROBLEMES SOCIAUX
+
3. MOTIF SIMPLE / CHUTES A REPETITIONS

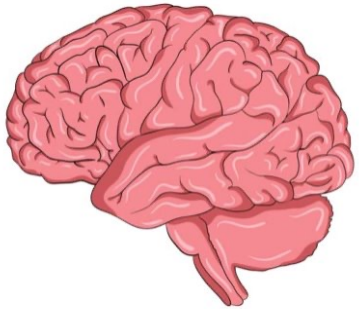
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

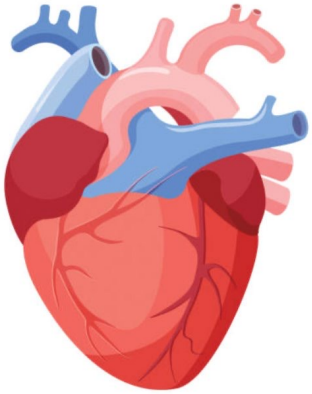
2. ÉVALUER & TRIER

Les trois grandes détresses

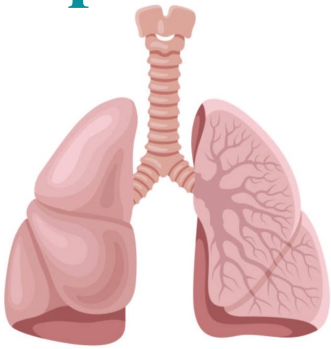
Neurologique



Circulatoire



Respiratoire



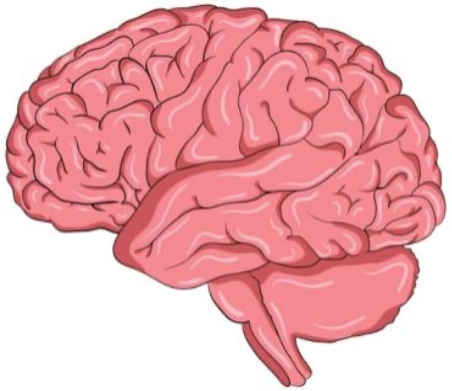
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Neurologique

Conscience / Vigilance
Comportement
Déficit



Déficit neurologique :

1 : Moteur
2 : Sensitif
3 : Langage

Paramètres vitaux :

Glasgow
Etat de conscience (trouble cognitif)

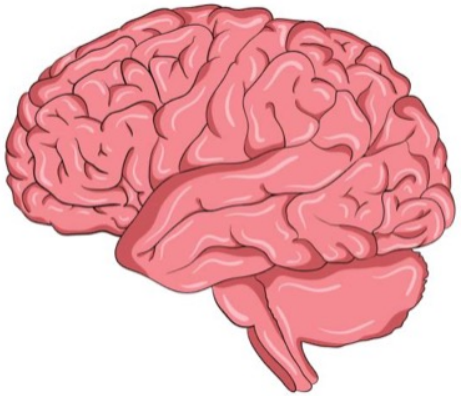
⚠ Confusion sans déficit = pas d'AVC / AIT

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Neurologique



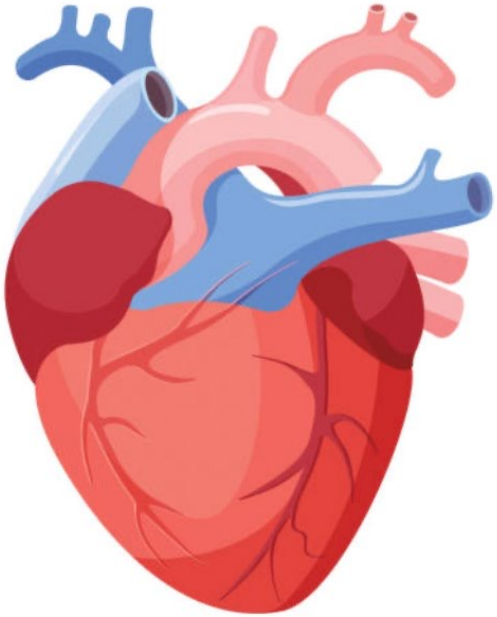
- Confusion sans déficit = **pas d'AVC / AIT (Orange / Jaune)**
- Déficit neurologique constatée ou transitoire < 4h30 / 6h = **SAUV (Rouge)**
- Déficit neurologique constatée ou transitoire > 6h et – de 24h = **Hors délai (Rose)**

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Cardiologique



Paramètres vitaux :

Fréquence cardiaque
Tension artérielle
Perfusion systémique

Clinique :

Perfusion systémique

Perfusion systémique :

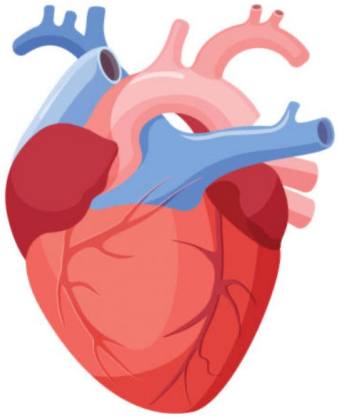
Peau : TRC / marbrures
Cerveau : baisse de la vigilance / sd confusionnel / coma
Rein : Oligo-anurie

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Cardiologique



- FC augmentée + perfusion systémique anormale + TA normale = **Insuffisance circulatoire compensée (Orange)**
- FC augmentée + perfusion systémique anormale + HypoTA = **Insuffisance Circulatoire décompensée (Rouge)**
- FC augmentée + perfusion systémique normale + TA normale = **Pas d'insuffisance Circulatoire (Jaune / Bleu)**

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

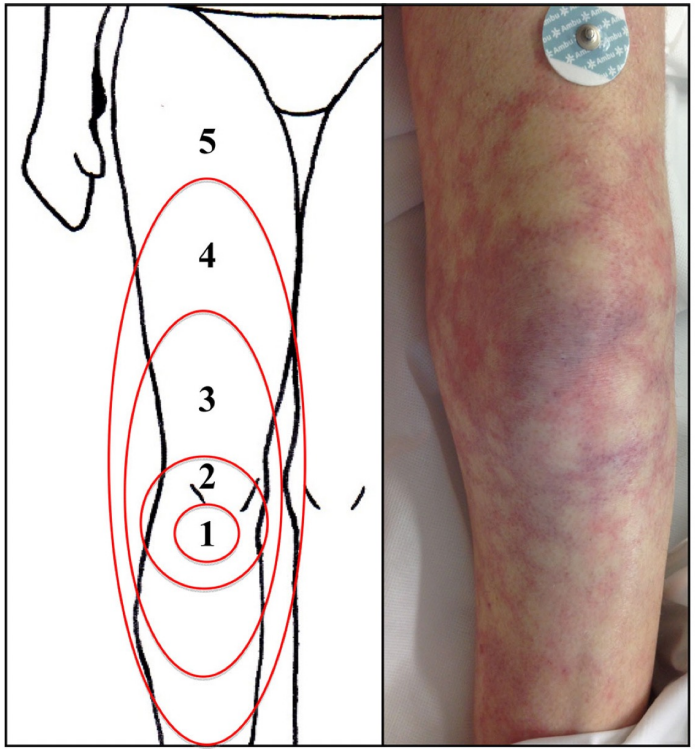
2. ÉVALUER & TRIER

Les marbrures

Traînées violacées des téguments

- Au niveau des genoux
- Au niveau des flancs à un stade plus tardif, voire généralisées

Secondaires à une diminution du débit sanguin provoquant une vasoconstriction des vaisseaux cutanés.



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Les chocs

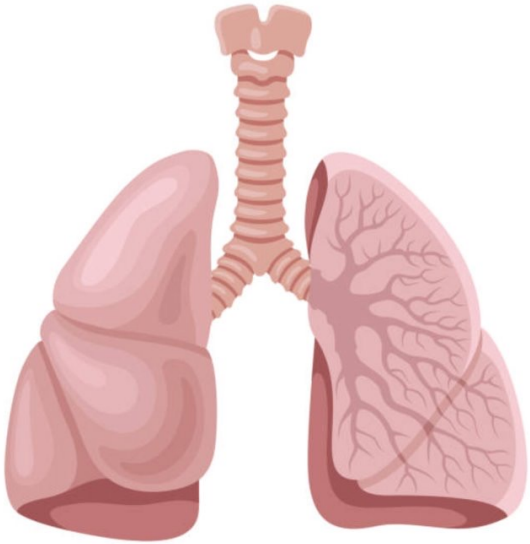
CHOC CARDIOGÉNIQUE	Le coeur n'arrive pas à pomper assez de sang pour assurer les besoins de perfusion de l'organisme
CHOC HYPOVOLÉMIQUE	Hypovolémique "Faible" "Volume" "dans le sang" Diminution du volume intra-vasculaire
CHOC SEPTIQUE	Causé par une infection étendue d'une bactérie ou d'un virus
CHOC ANAPHYLACTIQUE	Réaction allergique sévère
CHOC NEUROGÉNIQUE	Vasodilatation de durée étendue à cause d'un déséquilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Respiratoire



Paramètres vitaux :

Saturation en oxygène (SpO2)

Fréquence respiratoire

⚠ Pas de SpO2 **SANS** Fréquence respiratoire

Clinique :

Travail respiratoire

Battement des ailes du nez (nourrisson)

Balancement thoraco-abdo

Muscles intercostaux (tirage intercostal)

Hypoxie (désaturation)

Cyanose ; Tachycardie ; Trouble neurologiques

Hypercapnie

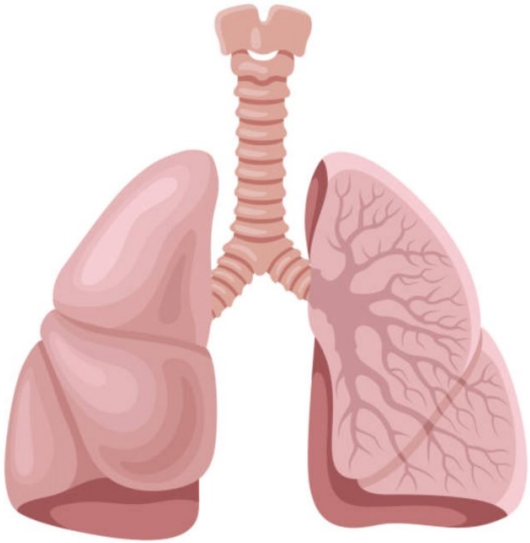
Sueurs ; Troubles neurologiques

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Respiratoire



DRA + Hypoxie + Pas de troubles neuro + Correction avec O2 passif

=

Insuffisance respiratoire compensée

DRA + Hypoxie + Troubles neuro + pas de correction avec O2 passif

=

Insuffisance respiratoire décompensée

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

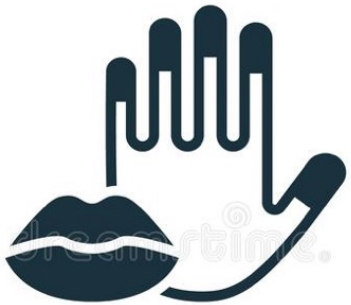
2. ÉVALUER & TRIER

Cyanose

Coloration violacée, bleutée des téguments (extrémités, doigts, orteils, lèvres, oreilles) traduit un manque d'oxygène

- Dans des situations graves :
  - Insuffisance respiratoire sévère
  - Etat de choc

- Remarque :
  1 membre cyanosé : probable ischémie



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

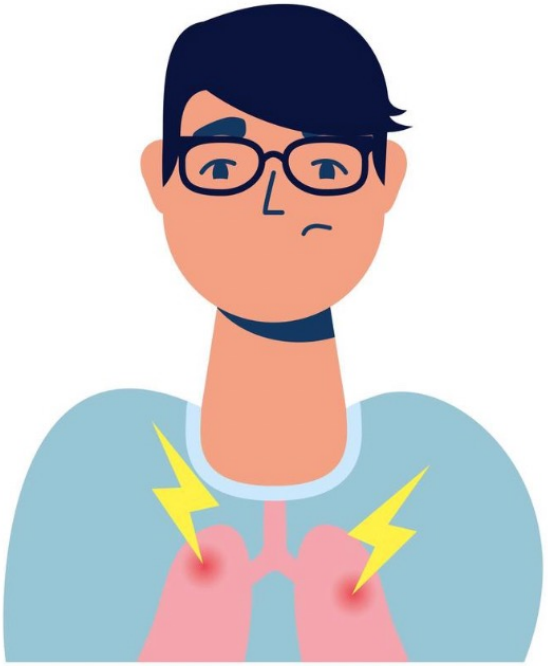
2. ÉVALUER & TRIER

Dyspnée – Détresse Respiratoire Aigue

⚠ **Dyspnée = c'est le patient qui le dit = sensation de respiration désagréable et gênante.**

- Polypnée avec FR > 20/min
- Gène à la parole
- Utilisation des muscles respiratoires accessoires :
  - Tirages / Balancement thoraco-abdominal (BTA)

Dans l'IOA, parler de détresse respiratoire aiguë (DRA)



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

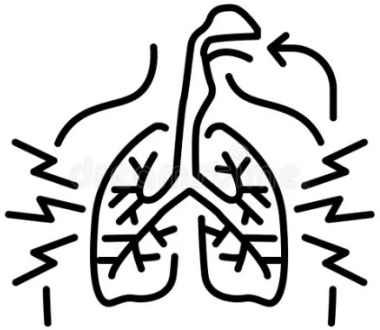
2. ÉVALUER & TRIER

Tirage - Balancement

⚠ **Pas la même chose**

➜ **Tirage** = Phénomène dans lequel les tissus mous de la cage thoracique sont aspirés vers l'intérieur de celle-ci lors de l'inspiration.

➜ **Balancement** = Phénomène de recul de la paroi antérieur de l'abdomen à l'inspiration = Respiration paradoxale.



Il peut être difficile de faire la différence, en particulier lorsqu'il existe une polypnée. Dans ce cas, la palpation permet en général de trancher.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Autres rappels

L'ictère

Coloration jaune ou jaunâtre de la peau et/ou du fond d'œil

Appelé couramment « jaunisse »

 Examen physique +++

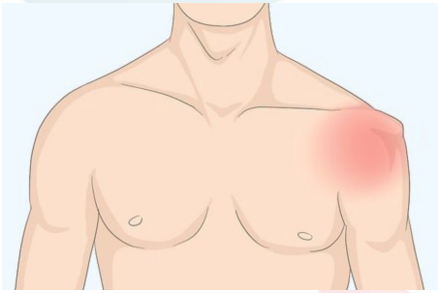


Traumatismes

Observation +++

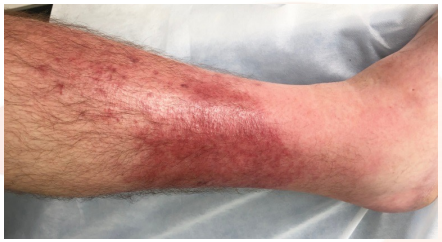
Déformation +/-

Luxation = signe de l'épaulette



Dermatologies

➢ Erysipèle



➢ Purpura



➢ Fasciite



➢ Fasciite nécrosante



Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Malaise

Dois figurer dans votre IOA

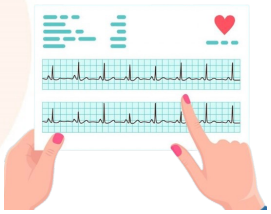
AVEC prodromes : vertiges, douleur, nausées, bourdonnements d'oreilles...

SANS prodromes = **SYNCOPE** = Scope

AUTRES : TC, PC, Douleur thoracique

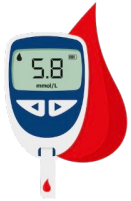
SOINS PARTICULIERS

ECG
POUR TOUS



+

HGT



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Douleur thoracique

Dois figurer dans votre IOA

HEURE DE DEBUT

LOCALISATION

TYPE : pique, pince, serre, brûle...

IRRADATION : bras, mâchoire, dos...

ARRIVEE : au repos, à l'effort

APPARITION : Progressive / Brutale

PRESENTE A L'IOA OU NON ?

CONTINUE OU DISCONTINUE

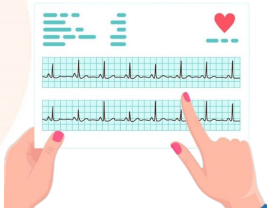
DYSPNEE ASSOCIEE

FACTEURS DE RISQUES :
Tabac, Cholestérol, HTA, Diabète, Dyslipidémie, Surpoids

ATCD familiaux :
IDM < 60ans

SOINS PARTICULIERS

ECG
POUR TOUS



+

TENSION ARTERIELLE
Aux 2 bras



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

AVC / AIT

HEURE DE DEBUT

SYMPTÔMES

Déficit moteur et/ou sensitif



Troubles du langage



Troubles de la vision



Pupilles symétriques et réactives



Vertiges (types)



LA CONFUSION N'EST PAS SIGNE D'UN AVC

DEFICIT < 4h30
=
ALERTE THROMBOLYSE
=
ROUGE

DEFICIT > 6h & < 24h
=
NIHSS (dans l'heure)
=
ROSE

SOINS PARTICULIERS

DECUBITUS
0° strict



+

TENSION ARTERIELLE
Aux 2 bras



+

HGT



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Douleur abdominale

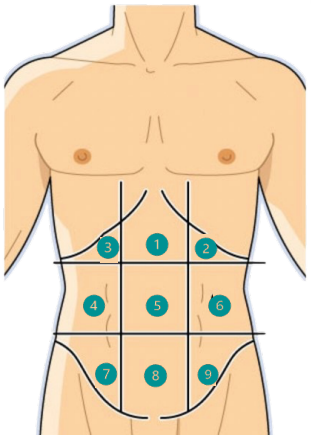
Dois figurer dans votre IOA

SFU (signes fonctionnels urinaires) : Brûlures mictionnelles, hématurie

TRANSIT : Gaz ? Selles ? Diarrhée ?

AUTRES : Abdomen souple, distendu ? Douloureux à la palpation
Nausées / Vomissements (type ?)
Irradiation lombaire

LOCALISATION :



1. Epigastre
2. Hypochondre Gauche
3. Hypochondre Droit
4. Flanc Gauche
5. Région périombilicale
6. Flanc Droit
7. Fosse iliaque Droite
8. Hypogastre
9. Fosse iliaque Gauche

\+ **FEMME**
Date des dernières règles
Moyen de contraception
Risque de grossesse

SOINS PARTICULIERS

BANDELETTE URINAIRE



HOMME

FEMME
Seulement si SFU

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Dyspnée / D.R.A

Dois figurer dans votre IOA

SIGNES CLINIQUES

Signes de lutte respiratoire : Tirage, balancement thoraco-abdominal, polypnée, bradypnée

Autres signes : Marbrures, difficultés à la parole, cyanose, sueur, douleur thoracique associée...

ATCD : BPCO (SpO2 de base), Asthme (DEP)

DYSPNEE = SENSATION D'UNE RESPIRATION DIFFICILE ET INCONFORTABLE RESSENTIE DANS UNE SITUATION QUI NORMALEMENT N'ENTRAÎNE AUCUNE GÊNE RESPIRATOIRE

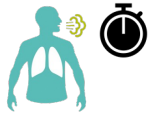
SOINS PARTICULIERS

POSITION DEMI-ASSISE



+

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Crisme d’asthme

Dois figurer dans votre IOA

NOMBRE DE CRISES

HEURE DE DEBUT → DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?

OBSERVANCE DU TRAITEMENT

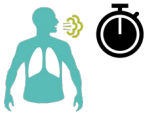
DIFFICULTES A LA PAROLE : TEST DES 10 SECONDES

Signes de lutte respiratoire : Tirage, balancement thoraco-abdominal, polypnée, bradypnée

ATCD : Hospitalisation en réanimation = critère de gravité !

SOINS PARTICULIERS

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



+

PEAK FLOW (DEP)



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Vertiges

Dois figurer dans votre IOA

HEURE DE DEBUT

ELIMINER UN AVC/AIT

APPEL MAO SI VERTIGES < 4h30

TYPES :

- **ROTATOIRE**
- **QUI TANGUENT**

- **POSITIONNELS**
- **NON POSITIONNELS**

NAUSEES / VOMISSEMENTS

VERTIGES POST TRAUMATISME CRÂNIEN ?

SOINS PARTICULIERS

HGT



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Saignement

Dois figurer dans votre IOA

LOCALISATION

- **SELLES = MELENA**
- **URINES = HEMATURIE**
- **VOMISSEMENT = HEMATEMESE**
- **CRACHAT = HEMOPTYSIE**

QUANTITE

- **TRACE**
- **½ VERRE**
- **1 VERRE**

ACTIF OU NON

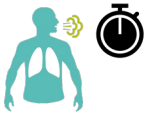
DUREE

AVEC OU SANS ATC / AAP

SIGNES ASSOCIES : Marbrures / DRA / Pâleur ...

SOINS PARTICULIERS

FREQUENCE RESPIRATOIRE



+

SpO2



+

HEMOCUE



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Traumatisme crânien

Dois figurer dans votre IOA

SIGNES CLINIQUES :

- **PERTE DE CONNAISSANCE (DUREE)**
- **NAUSEES / VOMISSEMENTS**
- **VERTIGES**
- **TROUBLES DE LA VISION**
- **SIGNES NEUROLOGIQUES**
- **ATC / AAP**

SOINS PARTICULIERS

HGT



+

GLASGOW



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Traumatisme

Dois figurer dans votre IOA

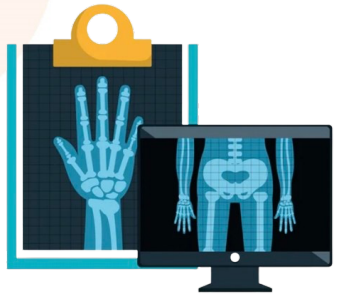
SIGNES CLINIQUES :

- **DEFORMATION**
- **RACCOURCISSEMENT DU MEMBRE**
- **PLAIE OUVERTE**
- **MOBILITE**
- **SENSIBILITE**
- **POULS DU MEMBRE EN AVAL**
- **COULEUR**
- **CHALEUR**

TRC (TEMPS DE RECOLORATION CUTANEE)

SOINS PARTICULIERS

PROTOCOLE
« DEMANDE ANTICIPEE
DE
RADIOGRAPHIE »



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Plaies

Dois figurer dans votre IOA

LOCALISATION

SUTURABLE OU NON

TAILLE (CM ENVIRON)

SAIGNEMENT ACTIF OU NON

HEURE DE DEBUT → DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?

MOBILITE / SENSIBILITE

ALLURE

- **DELABRANTE**
- **LARGE**
- **COMPLEXE**
- **SOUILLEE**
- **SUPERFICIELLE**
- **DERMABRASION**

ECOULEMENT

- **EN NAPPE**
- **EN JET**

VACCIN ANTI-TETANIQUE A JOUR ?

SOINS PARTICULIERS

DETERSION
(eau + savon)



+

XYLOCAÏNE SPRAY



+

PANSEMENT HUMIDE
PROVISOIRE



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

AVP

Dois figurer dans votre IOA

- CINETIQUE (VITESSE)
- CEINTURE ?
- AIRBAG DECLECHE ?
- CASQUE ?
- ETAT DU VEHICULE ET DU CASQUE
- PERTE DE CONNAISSANCE INITIALE
- AMNESIE DES FAITS
- SURVEILLANCE TRAUMA ABDO / THO
- DOULEUR RACHIS / CERVICAL
- SIGNES NEUROLOGIQUES

SOINS PARTICULIERS

HEMOCUE



+

BANDELETTE URINAIRE



(Seulement si nécessaire)

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Dextro / Cétonémie

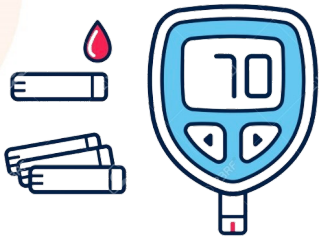
DEXTRO (HGT) POUR



- **VERTIGES**
- **VOMISSEMENTS**
- **MALAISE**
- **DIABETIQUE**
- **CONVULSIONS**
- **TROUBLE NEUROLOGIQUES**
- **TRAUMATISME CRÂNIEN**
- **TROUBLES DU COMPORTEMENT**

HGT > 3g

CETONEMIE



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Médi-mémo

Céphalées

Dois figurer dans votre IOA

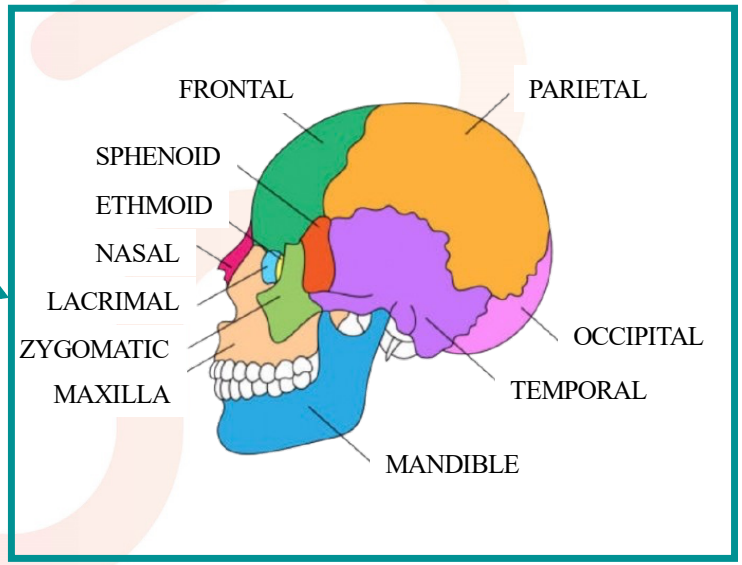
SIEGE

INSTALLATION

- **BRUTALE (« coup de tonnerre »)**
- **PROGRESSIVE**

TYPE

- **PULSATILE**
- **CONTINUE**



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Brûlure

THERMIQUE

90%

Les plus courantes. elles sont liées à un contact avec un liquide brûlant ou avec des flammes.

CHIMIQUE

3 à 5%

Les brûlures chimiques sont dues à la réaction des tissus en contact avec des substances nocives, comme les nettoyants industriels, les solvants, le pétrole…

ELECTRIQUE

5 à 7%

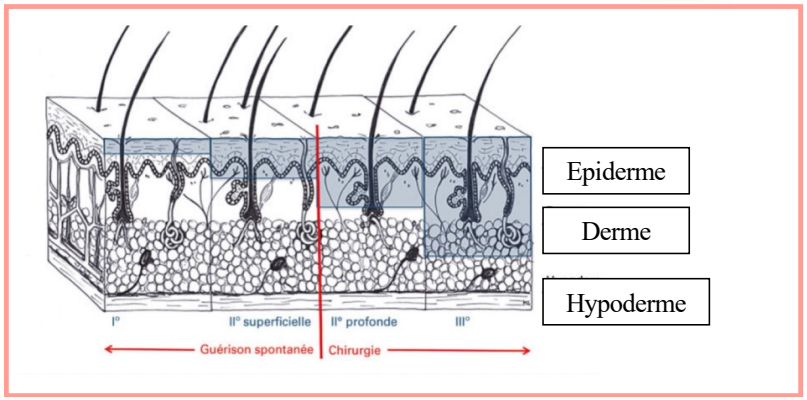
Les brûlures électriques sont toujours graves.

Domestic : 220 V
Haute tension : 1000 V

CLIMATIQUE

Causée par le changement de température extrême. Les extrémités du corps sont les plus touchées.
Deux types :
Crevasses et gerçures *(dues à une déshydratation due au froid).*
Engelures *(atteinte de la peau sans déshydratation).*

ANATOMIE



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

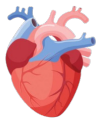
2. ÉVALUER & TRIER

Brûlure

1

FONCTIONS VITALES

ABECEDAIRE DE L'URGENCE VITALE

A	B	C	D	E
				
AIRWAYS	**BREATHING**	**CIRCULATION**	**DISABILITY**	**ENVIRONNEMENT**
Libération des voies ariennes & protection du rachis cervical	Respiration & ventilation	Contrôle de l'hémorragie & de l'état hémodynamique	Etat neurologique	Domicile, travail, extérieur, ...

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

2. ÉVALUER & TRIER

Brûlure

2

EVALUATION DE LA BRÛLURE

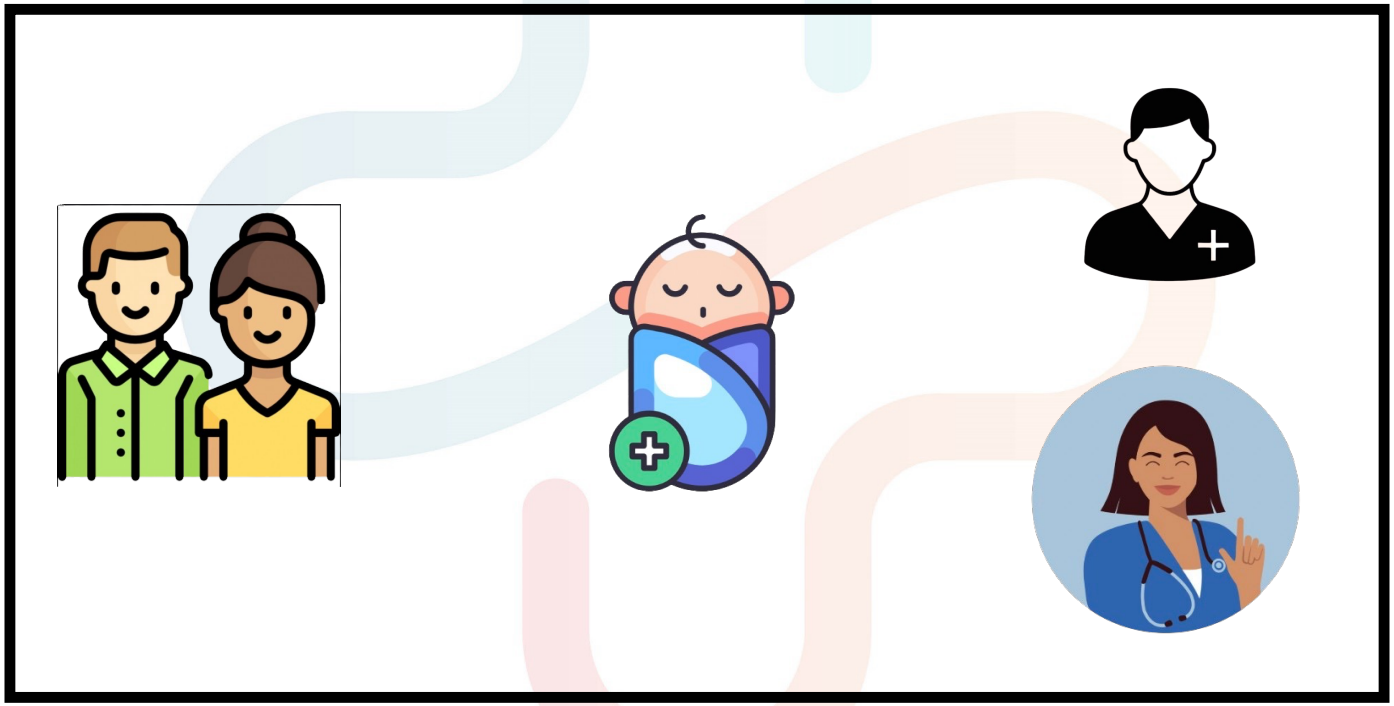
S	P	L	T	C
				
SURFACE	**PROFONDEUR**	**LOCALISATION**	**TERRAIN**	**CIRCONSTANCES**
Evaluation de la surface brûlée. Règle des 9 de Wallace	Reconnaître le degré de brûlure – 2ème & 3ème degré (1er = Erythème)	Gravité en fonction de la zone. Visage, mains, pied et périnée = Urgences Vitales	Antécédents médicaux ; Âge ; Comorbidités (OH, Athérome, Diabète, Immunosuppression, Ins. Cardiaque).	Agents causals : Electrique Chimique Thermique Climatique

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Prise en charge de l’enfant



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

L'IOA et la pédiatrie



- Evaluer la conscience
- Déshabiller *(si nécessaire)*
- Evaluer l'A/B/C *(+ entretien, + P.V)*
- Peser le patient, si nécessaire *(non réalisable à St-Jo, mais demander aux parents si enfants à perdu du poids).*

- **Entretien avec les parents essentiellement et rassurer**

HYPOXIE = 1er cause d'ACR chez l'enfant (ou hypoxémie)

- **A : Airways :** Voie aérienne libres ou à risque *(N.N à 6 ans : respiration nasale seulement).*
- **B : Breathing :** Fréquence ; Travail : signes de lutte ; Volume : amplitude ; Oxygénation : SpO2.
- **C : Circulation :** FC ; TA ; Perfusion périphérique : TRC.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

L'IOA et la pédiatrie

Anamnèse : *(essentiellement avec les parents)*

- Motif
- Evolution des symptômes
- Comportement de l'enfant *(pleure, cris, ...)*
- Signes associés
- ATCD (carnet de santé ?)
- TTT déjà instauré et effets

Vigilance pour les nourrissons < 3 mois

Orientation :

- M.G ou Urgences pédiatriques Necker.
- PEC SAUV (Appel SAMU pour transfert).

Aide mémo :

- Enfant avec fièvre : *ATCD = Crise convulsive ; Pyélo ; Retour de l'étranger*
- Enfant avec diarrhée : *quantité ; consistance (couche, body, ...) ; alimentation*

- Fièvre – de 48h, bien toléré → MG
- Perte de poids → MG / Urg pédiatrique
- Diarrhée → MG / Urg pédiatrique
- Nez bouché : DRP + évaluation SpO2 → MG / Urg pédiatrique



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Notion de psychiatrie

Définition :

- **Agitation :** perturbation du comportement avec excitation psychomotrice parfois associée à une hyperactivité psychique, une hyper expressivité émotionnelle, une perte de contrôle du comportement.
- **Agressivité :** Comportement se manifestant par de l'hostilité visant, consciemment ou non, à nuire, contraindre, dégrader et/ou détruire, de façon réelle, imaginaire ou symbolique.
- **Violence :** usage intentionnel de la force physique, plus imprévisible et incontrôlable que l'agressivité, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, dirigée contre les autres ou soi-même, pouvant avoir des conséquences extrêmes (meurtres, invalidité, …).

Facteurs favorisants :

- **Humains :** stress, anxiété, indifférence « je n'ai pas le temps », manque d'information et de communication, discours contradictoires des soignants, attente, douleur, …
- **Organisationnels :** fonction IOA incomprise, délai pour exams, obtention d'un lit, transfert ambulance, transmissions soignantes.
- **Environnementaux :** architecture des locaux, espaces confinés, « le couloir ou salle d'attente », lieu de passage (va et vient), environnement bruyant, odorant.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Notion de psychiatrie

Addictions :

- **Alcool à** IOA = score de sevrage alcoolique (score de Cushmann)
- **Toxicomanie à** MDMA / Ecstasy ; Cocaïne / Crack ; Opiacés ; Poppers ; …

Cushmann = FC / TA / FR / Tremblements / sueurs / agitations / Tb sensorielle.

Troubles psychiatriques :

- 25% de la population mondiale est concernés à un moment ou à un autre de sa vie par un trouble mentale (OMS, 2013).
- En France : Schizophrénie (près de 1%) ; Trouble de l'anxiété généralisé (près de 2%) ; Etat dépressif caractérisé sévère (près de 3%).

Attention à l'image véhiculé par la fiction : 72% des personnages de fiction = malades mentaux violents.

3. ADAPTER LE TRI AUX SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Notion de psychiatrie

Patient suicidaire :

- Déshabillage (coffre + vestiaire) = mise en sécurité (téléphone portable avec patient si accord MAO/Psy)
- Habillage avec tenue rose
- Installation en box
- Prévenir équipe de psychiatrie

--> Seulement si nécessite d'être prise en charge en zone couchée.

Patient délirant :

Attention aux adhésions aux dires du patient : attitude soignante

- Evaluer la compliance (risque de fugue et agressivité).

--> Si risque de fugue, mettre en place la procédure fugue (Déshabillage (coffre + vestiaire) + Habillage avec tenue rose)

- Attention aux causes somatiques et surtout toxiques.
- Installation en box (si possible) + prévenir équipe psy

Patient paniqué :

- En fonction de l'intensité de la crise (Tri) : Installation en Box S.B *(installation en box diminue les stimuli).*
- Traitement SB en accord avec le MAO
- Prévenir équipe psy

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Protocole demande anticipée de bilan radiologique



Inclusion

- ❑ 16 ans et + ayant été informé du protocole
- ❑ Patient consultant pour un traumatisme simple et isolé du membre supérieur ou du membre inferieur et n'ayant aucune radiographie antérieure pour le même traumatisme.
- ❑ PEC adéquate de la douleur
- ❑ Faisabilité : patient coopérant, inspection facile.



Exclusion

- ❑ Patient n'ayant pas consenti au protocole
- ❑ Douleur non traumatique
- ❑ Traumatismes multiples ou signes clinique évoquant des traumatismes multiples
- ❑ Circonstances non mécaniques du traumatisme (ex : malaise, syncope, épilepsie) ayant provoqué une chute
- ❑ Accident à forte cinétique
- ❑ Signes évocateurs d'une fracture ouverte : plaie associée et/ou signes de souffrance cutanée
- ❑ Trouble sensitifs (perte de sensibilité) en aval de la zone traumatisée.
- ❑ Instabilité hémodynamique ou trouble de la vigilance
- ❑ Agitation liée à une confusion, une démence, à la consommation de stupéfiant ou d'alcool ; agressivité manifeste.
- ❑ Femme enceinte ou se déclarant l'être
- ❑ Situation peu claire créant un doute.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Protocole demande anticipée de bilan radiologique

Modalités en fonction de la zones anatomiques

Modalités de demande



- Localisation
- \+
- Côté
- \+
- Incidence



- Epaule → *(Face + Profil, +/- Clavicule)*
- Coude → *(Face + Profil +/- Tête radiale)*
- Avant-bras → *(Face + Profil)*
- Poignet → *(Face + Profil +/- incidence scaphoïde)*
- Main → *(Face + Profil)*
- Doigts → *(Face + Profil + préciser doigt, phalange P1,P2,P3)*



- Genou → *(Face + Profil)*
- Jambe → *(Face + Profil)*
- Cheville → *(Face + Profil +/- Pied Face + Profil)*
- Pied → *(Face + Profil)*
- Orteil → (*Pied Face + Profil)*



- Bassin → *(Face + Profil)*
- Hanche → *(Face + Profil)*

Traumatisme **simple** & **isolé**

TRI IOA **VERT**

TRI IOA **ROSE**

Demande anticipée de radiographie



Attention la non prise de paramètres vitaux est seulement applicable au tri vert

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

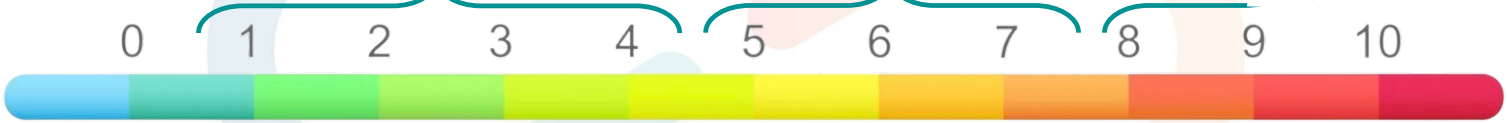
4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Douleur

EVALUATION

EN (1er intention)
Algoplus® (sujets âgés, non communicants)
EVS, si EN impossible

MOYEN NON MEDICAMENTEUX (immobilisation, glaçage)



DOLIPRANE ORO®
500MG x 2

DOLIPRANE ORO®
500MG x 2
+
ACTISKENAN ORO®
10MG

DOLIPRANE ORO®
500MG x 2
+
ACTISKENAN ORO®
10MG
ET / OU
TITRATION MORPHINE IV

REEVALUATION A 45MIN

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

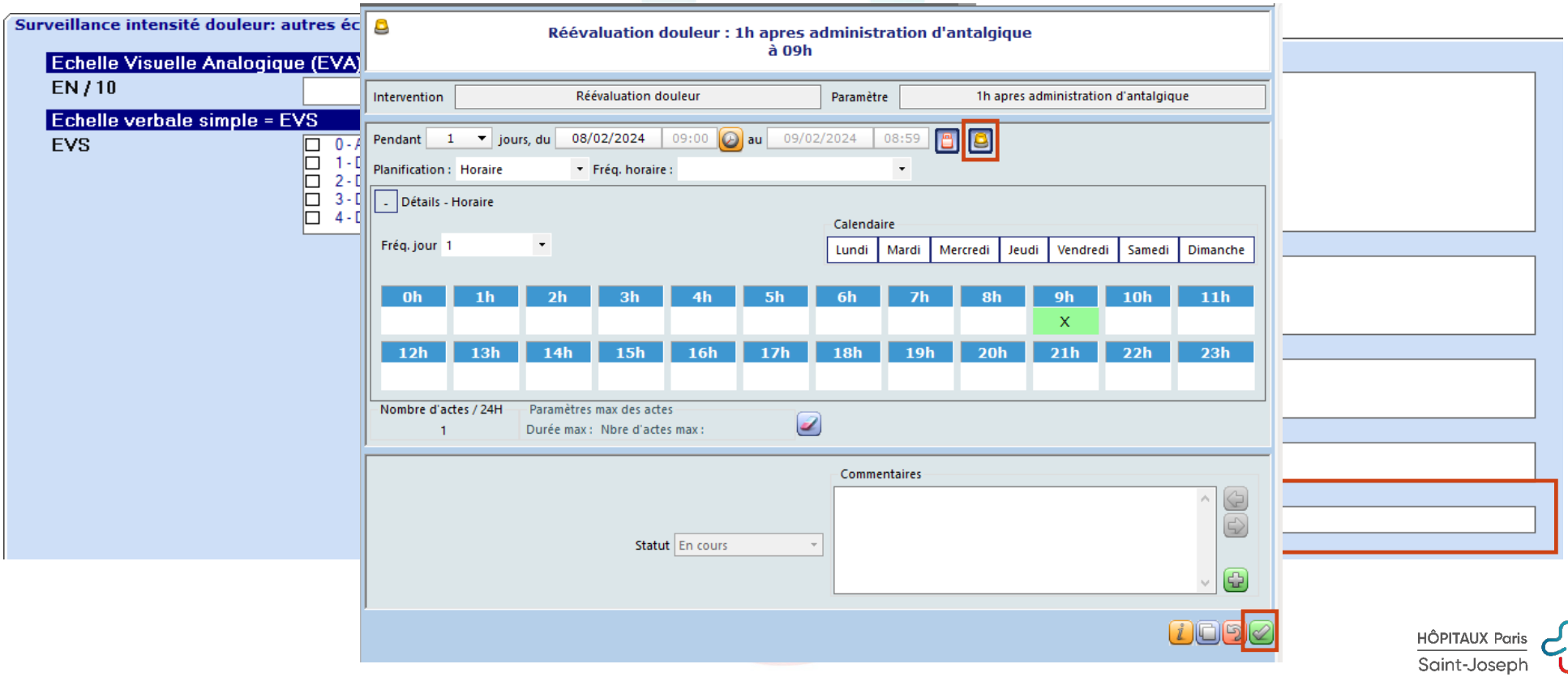
Douleur

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Douleur

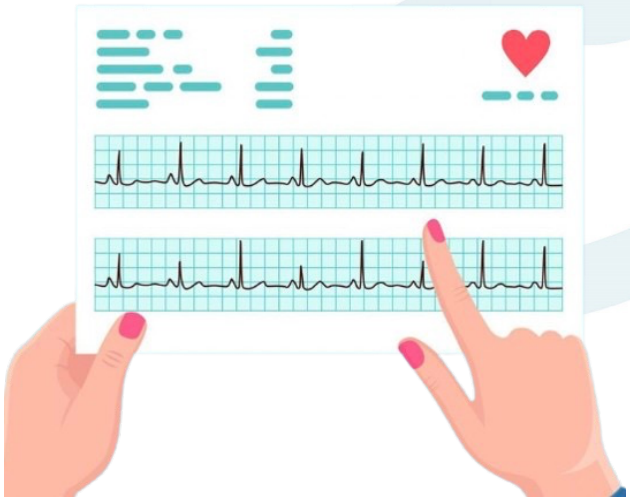


HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Protocole ECG



DOULEUR THORACIQUE / EPIGASTRIQUE

DOULEUR DORSALE (OMOPLATE)

DOULEUR EPAULE GAUCHE (SANS TRAUMA)

MALAISE

ANOMALIE BILAN SANGUIN :

- **HYPER / HYPOKALIEMIE**
- **TROPONINE AUGMENTEE**

HYPOTHERMIE

FREQUENCE CARDIAQUE < 45 ou > 120

ANEMIE < 10g/dL HB + ATCD : IDM / STENT / PONTAGE

IMV

TRAUMA THORACIQUE (nécessitant d'être allongé)

SI INSTALLATION A LA SAUV → PAS D'ECG A L'IOA

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Hypo/Hyperkaliémie

Connaître les définitions :

- Hyperkaliémie = K+>5,5 mmol/l
- Hyperkaliémie menaçante = K+>6,5 mmol/l ou toute hyperK avec signes ECG
- Hyperkaliémie sévère chez dialysé chronique : K+ >7 avec signes ECG et/ou signe clinique
- Evoquer le diagnostic :
  Trouble du rythme cardiaque, parésie inexpliquée, prise de traitements hyperkaliémiants (potassium, spironolactone, digoxine), insuffisance rénale connue, contexte de rhabdomyolyse, contexte d'acidocétose diabétique



Réaliser un ECG

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

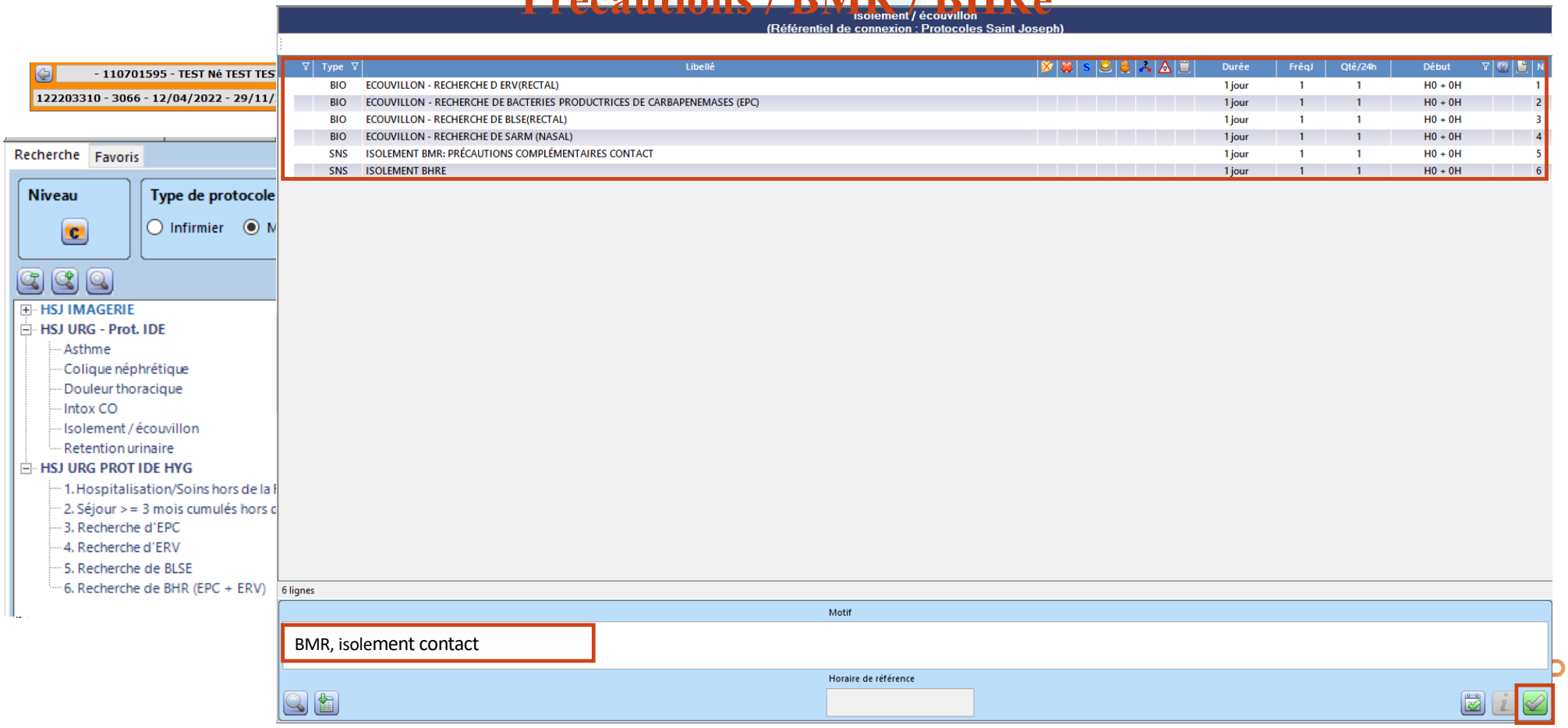
Précautions / BMR / BHRe

- Ouvrir le dossier du patient, ou regarder dans la liste si isolement
- Si isolement ou EPC/ERV/BLSE/SARM à dépister → prescrire l'isolement / les écouvillons dès l'IOA
- Patient BHRe = isolement en box (matériel dans le box + IOA dans le box de zone)
  Si possible, même IDE qui fait IOA et les soins.
- Si voyage de + de 3 mois à l'étranger ou soins/hospitalisation à l'étranger =
  Isolement contact + Dépistage SARM, EPC, ERV, et BLSE.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Précautions / BMR / BHRe



Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Réorientation

- Appel au MAO avant réorientation obligatoire
- Noter le nom du médecin qui valide la réorientation + lieu de réorientation
- Tout patient réorienter doit avoir un motif IOA
- Les patients < 16 ans = IOA + Avis médecin avant réorientation
- Proctologie = seules les hémorroïdes objectivées à l'IOA peuvent être réorientés.
  NE PAS DONNER DE XYLOCAINE aux patients.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Mineur

- Patient mineur entre 16 et 18 ans
- Doivent être accompagné d'un majeur obligatoirement
- Isolement en box
- Autorisation de soins signé obligatoirement par les parents + scanner dans le dossier dès l'IOA.
  Si parents non présents, prévenir encadrement + demandé aux parents d'envoyer un mail donnant l'autorisation de soins.
  Je soussigne ….

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

CNA

- Demander le motif de la consultation à la police

- Si patient calme et coopérant, demander à la police de patienter en dehors du box
  → Secret professionnel.
  → Police à chaque porte IOA + Agent de sécurité à la porte vitrée

- Après évaluation → Appel MAO pour prévenir du CNA + Isolement en box (ou installation box MAO ou IOA 3)

- Si patient présente un risque pour le soignant, autorisation qu'un agent de police vous accompagne dans le box.
  Pas de question portant au secret professionnel.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Fondamentaux

4. SÉCURISER SA PRATIQUE

Fugue / Sortie à l’insu du service

- Attention à la différence : 2 procédures différentes.

- Fugue = Danger pour le patient
  - Remplir la fiche fugue dans le recueil soignant
    - Prévenir Encadrement
      - Transmission dans le dossier patient + FEI

- Sortie à l’insu du service = Pas de danger pour le patient
  - Remplir la fiche sortie à l’insu du service dans le recueil soignant

Si vous constatez une disparition (voir avec médecin pour statuer si fugue ou sortie).
Prévenir agent de sécurité SAU + recherche dans le service.
Appel du patient sur son numéro de téléphone.
Prévenir sécurité de l’hôpital

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Maintenant, à vous de vous entraîner avec les cas cliniques.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue